ANEMIE DU NOUVEAU-NE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Nagalo K[1]*, Savadogo H[2], Ouédraogo A[3].

[1] UFR SDS Université Joseph Ki-ZERBO, Unité de néonatologie, CHUP Charles de Gaulle, Ouagadougou

[2] UFR SDS Université Bernard Lédéa Ouédraogo, Servie de Pédiatrie CHUR Ouahigouya, Ouahigouya

[3] UFR SDS Université Bernard Lédéa Ouédraogo, Ouahigouya

PLAN

- ❖ INTRODUCTION
- ❖ OBJECTIFS
- ❖ MATERIELS ET METHODE
- ❖ RESULTATS
- ❖CONCLUSION

INTRODUCTION-ENONCE DU PROBLEME

INTRODUCTION-ENONCE DU PROBLEME (1/1)

- Période néonatale : immaturité grandes fonctions
- Anémie du nouveau-né : concentration en Hb ou d'hte < 2 ET en dessous de la moyenne pour l'âge postnatal
- Tous les nouveau-nés : **« anémie physiologique »**
- Problème de santé publique

INTRODUCTION-ENONCE DU PROBLEME (2/2)

- Afrique subsaharienne : 57,2 % (Cameroun), 16 % (Gabon)
- Burkina Faso : 42,6 % (Lompo, 2020), 17 % (Tamboura, 2015)
- CHUR-OHG : pas d'étude sur le sujet
- **But** : Contribuer à améliorer la santé du nouveau-né

OBJECTIFS

OBJECTIFS (1/3)

Objectif général

Etudier l'anémie chez le nouveau-né dans le service de pédiatrie du CHUR-OHG du 1er janvier au 31 décembre 2023

OBJECTIFS 2/3

Objectifs spécifiques

1. Déterminer la fréquence de l'anémie

2. Décrire les caractéristiques sociodémographiques des nouveau-nés anémiés

3. Décrire le tableau clinique de l'anémie du nouveau-né

OBJECTIFS (3/3)

4. Décrire les caractéristiques biologiques de l'anémie

5. Identifier les causes de l'anémie

6. Déterminer le devenir à court terme (intra hospitalier) des nouveau-nés anémiés

7. Déterminer les facteurs pronostiques de l'anémie

MATERIELS ET METHODE

MATERIELS ET METHODE (1/5)

- **Cadre de l'étude** : CHUR-OHG, Pédiatrie, Unité néonatologie
- **Type** : Etude **transversale à visée descriptive et analytique avec collecte rétrospective des données**
- **Période** : 1er janvier au 31 décembre 2023

MATERIELS ET METHODE (2/5)

❖ Population

Nouveau-nés hospitalisés durant la période

❖Critères d'inclusion

- NN à terme (Hb <14 g/dl et/ou Hte < %) ou prématuré (Hb quelle que soit la cause de cette anémie, hospitalisé.

MATERIELS ET METHODE (2/5)

❖Critères de non-inclusion

Transfusion (avant hospitalisation ou avant début de l'étude)

❖Echantillon

NN remplissant les critères d'inclusion

METHODOLOGIE (3/5)

- **Collecte des données** : Collecte rétrospective
  - ✓ Sources

    Registres hospitalisation

    Dossiers cliniques patients

    Fiches de référence & évacuation

METHODOLOGIE (4/5)

❖ Variables de l'étude

- ✓ Facteurs sociodémographiques
- ✓ **Déroulement de la grossesse et l'accouchement**
- ✓ Données cliniques et paracliniques
- ✓ **Données évolutives**

METHODOLOGIE (5/5)

❖ Traitement des données

- ✓ Saisie : micro-ordinateur
- ✓ Analyse : STATA/MP 16.0

❖ Considérations éthiques

- ✓ Autorisations
- ✓ Respect confidentialité, anonymat des patients

RESULTATS

RESULTATS (1/14)

1. Caractéristiques épidémio-sociodémographiques

- Fréquence : → 17,1 % (195/1 143)
- Age moyen : 3,04 ± 0,5 j [0, 28]
- Sexe = { **M = 53 %** / **F = 47 %** } → sex-ratio = 1,1

RESULTATS (2/14)

2. Données à l'admission

❖ **Mode : transfert = 44,3 % ; évacués = 26,5 %**

❖**Motif :**

- détresse respiratoire = 33,5 %
- prématurité = 22,2 %
- fièvre = 14,1 %

RESULTATS (3/14)

3. Antécédents maternels

- **CPN : 90,3 % moyenne 3,6 ± 0,1**

- **Prophylaxie**
  - **Anti anémique : 78,4 %**
  - **anti palustre : 82,2 %**

RESULTATS (4/14)

3. Antécédents pernatals

- **Age gestationnel**
  - **Terme : 54,1%**
  - **Prématurité : 45,9 %**
- **Gémellité (n = 37) : 20 %**

RESULTATS (5/14)

3. Antécédents postnatals

❖ **Poids de naissance**

✓ Poids moyen : 2 189,8 g ± 60,2 [550 – 4 220]

✓ Faibles poids de naissance : 62,2 %

❖**Vit K1 à la naissance** : 27,6 %

RESULTATS (6/14)

4. Signes cliniques

- Difficulté respiratoire : 57,3 %
- Saignements : 8,1%
- Fièvre : 45,9 %
- Ictère : 43,3 %

RESULTATS (9/14)

5. Signes biologiques

- Tx moyen Hb : 10,8 ± 0,1 g/dl [4,4, 13] normocytaire normochrome
- Anémie sévère (< 7 g/dl) : 4,3 %
- Tx moyen plaquettes : 1 6405,3 ± 9 309,6 /µl
- Hyperleucocytose : 14 %
- CRP : 39,7 %
- Goutte épaisse positive : 31,4 %

RESULTATS (11/14)

6. Etiologies probables de l'anémie

- Infections néonatales : 55,1 %
- Prématurité : 21,6 %
- Paludisme : 31,4 %
- MHNN : 9,2 %

RESULTATS (12/14)

7. Devenir à court terme

- Durée moyenne d'hospitalisation : 11,4 ± 0,8 j
- Complications : 50,8 %
- Mode de sortie
  - ✓ Normal : 63,8 %
  - ✓ Décès : 34,05 %

RESULTATS (13/14)

8. Causes probables de décès

- Détresse respiratoire : 34,9 %
- Extrême prématurité : 15,9 %
- Sepsis sévère : 9,5 %
- Défaillance multiviscérale : 9,5 %

RESULTATS (14/14)

9. Facteurs pronostiques

- **Réanimation :** ***p*** **0,005**
- **Mauvais état général :** ***p*** **0,001**

CONCLUSION

CONCLUSION

- Fréquence élevée, gravité
- Liens forts avec infection et prématurité
- Nécessité de stratégie de prévention

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION